



CONNAÎTRE VOTRE CYCLE

Un guide pratique et fondé sur les preuves pour comprendre vos hormones, vos symptômes et vos signes de fertilité, et savoir quand demander de l'aide.

ELSA · OSTÉOPATHE & PRATICIENNE EN SANTÉ FÉMININE

AVANT DE COMMENCER

DE LA CLARTÉ, PAS DE LA CONFUSION.

Chaque mois, votre cycle raconte une histoire. Ce guide vous apprend à la lire : ce qui est habituel, ce qui vaut la peine d'être noté, et les signes qui méritent l'avis d'un médecin. Il ne vous demande pas d'être parfaite. Seulement d'être curieuse.

TROIS FAÇONS D'UTILISER CE GUIDE

01

Lire

Les chapitres 1 à 6 expliquent le fonctionnement du cycle simplement, avec les repères chiffrés qu'utilisent les médecins.

02

Observer

Le chapitre 7 et les fiches à imprimer vous aident à recueillir un à trois cycles d'observations utiles.

03

Préparer

Le chapitre 8 transforme vos notes en une synthèse d'une page à apporter en consultation.

NOTE DE SÉCURITÉ

Ce guide est éducatif. Il vous aide à repérer des tendances, à mieux formuler vos questions et à préparer vos rendez-vous. Il ne pose pas de diagnostic, ne remplace pas votre médecin et n'est pas une méthode de contraception. Elsa est ostéopathe et praticienne en santé féminine, elle n'est pas médecin. Les repères cliniques cités proviennent des recommandations listées page 27, vérifiées en octobre 2026.

CONSULTEZ EN URGENCE SI VOUS AVEZ

- Des saignements qui traversent une serviette ou un tampon toutes les heures pendant deux heures ou plus, ou des règles abondantes avec vertiges, malaise ou cœur qui s'emballe.
- Une douleur pelvienne ou abdominale brutale et intense, surtout si une grossesse est possible, ou une douleur avec fièvre.
- De la fièvre, des vomissements, une éruption type coup de soleil ou une sensation de malaise avec un tampon ou une coupe en place : retirez-le et consultez.
- Des idées de vous faire du mal. Appelez le 15 ou le 112, ou le 3114 (prévention du suicide, France) ; 9-8-8 au Canada.

CE QUE VOUS TROUVEREZ ICI

—	L'ESSENTIEL	04
	Le guide en dix points	
01	LE CYCLE, UN SIGNE VITAL	05
	Les repères habituels et comment compter	
02	HORMONES ET PHASES	07
	Une carte simple qui reste exacte	
03	LES SIGNES DE FERTILITÉ	10
	Glaire cervicale, température, tests LH et applications	
04	LES SYMPTÔMES COMME SIGNAUX	13
	Quoi noter, SPM et TDPM	
05	QUAND CONSULTER	15
	Signes d'alerte et pathologies à connaître	
06	LES FONDATIONS ET LES ÉTAPES DE VIE	18
	Sommeil, alimentation, stress, mouvement, pilule, périménopause	
07	VOS PREMIERS MOIS D'OBSERVATION	20
	Comment observer, avec des fiches à imprimer	
08	PRÉPARER UNE CONSULTATION	23
	Apporter le schéma, pas seulement la douleur	
—	GLOSSAIRE ET RÉFÉRENCES	26
	Des mots simplifiés, des sources visibles	



À PROPOS DE L'AUTRICE

Je suis Elsa, ostéopathe (Master M.Ost., University College of Osteopathy, Londres) et praticienne en santé féminine, avec plus de sept ans de pratique clinique. J'ai écrit ce guide parce que j'ai vécu des années avec des règles douloureuses, un SPM marqué et aucune explication claire. Mon travail vient en complément de celui de votre médecin, jamais à sa place.

LE GUIDE EN DIX POINTS

01

Votre cycle est un **signe vital** : un changement de rythme, de flux ou de symptômes renseigne sur votre santé globale.

02

Chez l'adulte, un cycle de **24 à 38 jours** avec des règles de **8 jours maximum** reste dans les limites habituelles. À l'adolescence, il peut aller de 21 à 45 jours.

03

L'ovulation tombe rarement pile au 14^e jour. La **phase lutéale est la plus stable** ; c'est la phase avant l'ovulation qui varie le plus.

04

La **fenêtre fertile dure environ six jours** : les cinq jours qui précèdent l'ovulation et le jour de l'ovulation.

05

La glaire cervicale peut annoncer l'ovulation ; la température la **confirme seulement après coup** ; une application seule se trompe souvent de jour.

06

Des règles si douloureuses qu'elles vous empêchent de vivre sont **fréquentes, pas normales**, et méritent d'être explorées.

07

Les règles abondantes ont des signes concrets : changer de protection toutes les une à deux heures, des caillots de la taille d'une pièce, plus de sept jours de saignement.

08

Des troubles de l'humeur très marqués avant les règles peuvent relever du **TDPM**, une pathologie reconnue et soignable, diagnostiquée en notant deux cycles.

09

Sommeil, alimentation suffisante, gestion du stress et mouvement soutiennent l'ovulation. **Manger trop peu** ou un stress chronique peuvent la mettre en pause.

10

Un à trois mois de notes simples rendent une consultation **plus rapide, plus claire et plus utile**.

01

LE CYCLE, UN SIGNE VITAL

VOTRE CYCLE N'EST PAS UN BRUIT DE FOND.

Les règles sont la partie visible d'un rythme bien plus large, qui implique le cerveau, les ovaires, l'utérus, la thyroïde, le système du stress, le sommeil et l'alimentation. Quand quelque chose change dans cet ensemble, le cycle le montre souvent en premier.

LE REGARD DES EXPERTS

Le Collège américain des gynécologues-obstétriciens (ACOG) recommande de considérer le cycle menstruel comme un signe vital, au même titre que le pouls ou la tension, car son rythme, son flux et ses symptômes peuvent révéler un problème tôt.¹ La Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO) définit les limites qu'utilisent les médecins pour décrire un cycle habituel.^{2,3}

CE QUE VOTRE RYTHME PEUT RÉVÉLER

Le rythme

Durée du cycle, régularité, règles absentes, changements soudains.

Le flux

Nombre de jours de saignement, abondance, caillots, saignements entre les règles.

Les signaux

Douleur, humeur, sommeil, peau, digestion, énergie, libido, et le moment du cycle où ils apparaissent.

UNE MEILLEURE QUESTION QUE « EST-CE NORMAL ? »

Demandez-vous plutôt : **est-ce habituel pour moi, et est-ce que cela a changé ?** Un cycle imparfait après un voyage, une maladie ou un mois stressant est courant. Un nouveau schéma qui se répète sur deux ou trois cycles est une information sur laquelle agir.

Inutile de tout noter parfaitement. Il suffit d'assez d'observations pour reconnaître votre propre rythme, afin qu'un changement saute aux yeux.

À QUOI RESSEMBLE UN CYCLE HABITUEL ?

Ces repères sont une orientation, pas un verdict. Ils décrivent la majorité des personnes, et c'est à eux qu'un médecin comparera vos notes.

REPÈRE	ADULTES (FIGO) ^{2,3}	PREMIÈRES ANNÉES APRÈS LES PREMIÈRES RÈGLES (ACOG) ¹
Durée du cycle	24 à 38 jours	21 à 45 jours
Durée des règles	Jusqu'à 8 jours	Jusqu'à 7 jours
Régularité	Écart de 7 jours maximum entre le cycle le plus court et le plus long (9 jours avant 26 ans et après 41 ans)	Des cycles irréguliers sont fréquents ; un cycle de plus de 90 jours, même isolé, doit être vérifié
Abondance	Jugée selon son retentissement sur votre vie, pas selon un chiffre	Changer de protection plus souvent que toutes les 1 à 2 heures, c'est abondant

COMMENT COMPTER

Le jour 1

Le premier jour de **vrai saignement**, celui qui nécessite une protection. Les petites traces qui précèdent ne comptent pas.

La durée du cycle

Du jour 1 des règles jusqu'à la veille des règles suivantes.

L'ovulation

Elle survient en général 10 à 16 jours **avant** les règles suivantes. Dans une grande étude portant sur 600 000 cycles, seuls 13 % duraient exactement 28 jours. ⁴

La régularité

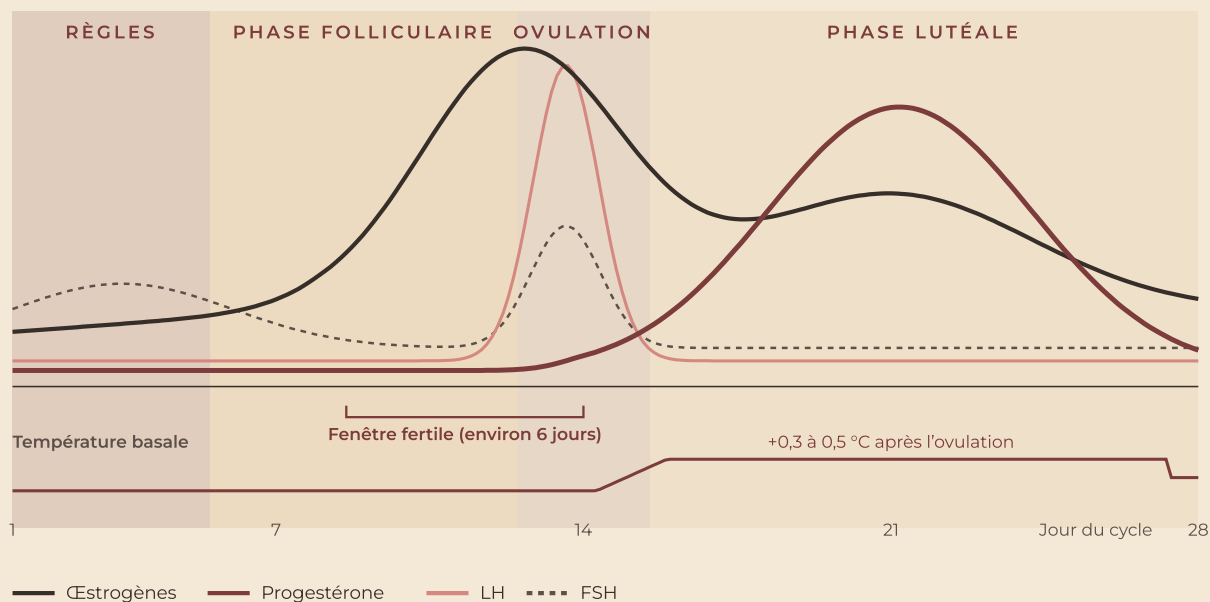
Comparez votre cycle le plus court et le plus long sur plusieurs mois. Un cycle en dit peu ; six en disent beaucoup.

VOTRE CYCLE EST UNE SÉRIE DE DONNÉES MENSUELLES. PAS BESOIN DE TOUT NOTER PARFAITEMENT : IL SUFFIT D'ÊTRE ASSEZ RÉGULIÈRE POUR VOIR VOTRE PROPRE SCHÉMA.

02 HORMONES ET PHASES

DEUX CYCLES, UN SEUL RYTHME.

En réalité, deux cycles avancent ensemble. Dans l'**ovaire**, un follicule mûrit, libère un ovule puis devient le corps jaune. Dans l'**utérus**, la muqueuse s'élimine, se reconstruit et se prépare. Les quatre « saisons » utilisées dans ce guide sont une carte pédagogique posée sur les deux.



Cycle schématisé de 28 jours, sans échelle. Dans la réalité, la phase folliculaire s'allonge ou raccourcit ; la phase lutéale est plus stable.

Avant l'ovulation

Les œstrogènes en hausse reconstruisent la muqueuse utérine et rendent la glaire plus humide. Cette phase peut durer d'environ 10 à 30 jours : c'est elle qui fait varier la durée du cycle.⁴

Après l'ovulation

Le corps jaune produit de la progestérone, qui stabilise la muqueuse et fait monter la température basale. Cette phase dure en général 10 à 16 jours, puis les hormones chutent et les règles arrivent.

LES QUATRE SAISONS, SIMPLEMENT.

01

Règles · jours 1 à 5 environ

La muqueuse s'élimine. Les hormones sont au plus bas. L'énergie peut baisser. Les crampes sont fréquentes ; une douleur qui perturbe votre vie n'est pas à subir en silence.

02

Phase folliculaire · jusqu'à l'ovulation

Les œstrogènes montent. Beaucoup ressentent plus d'énergie, d'envie de voir du monde ou de concentration. La glaire devient crémeuse, puis plus humide.

03

Ovulation · quelques jours

Le pic de LH déclenche l'ovulation. La glaire est souvent claire, glissante et filante. Certaines ressentent un petit tiraillement d'un côté ou une libido plus forte.

04

Phase lutéale · environ 10 à 16 jours

La progestérone monte, puis redescend s'il n'y a pas de grossesse. La température reste plus haute. Les symptômes prémenstruels, s'il y en a, apparaissent dans les derniers jours.

NUANCE IMPORTANTE

Les symptômes prémenstruels ne signifient pas que vos hormones sont « déséquilibrées ». La recherche suggère qu'ils viennent d'une sensibilité accrue du cerveau aux variations hormonales normales. Le stress, le manque de sommeil et l'alcool peuvent les amplifier, d'où l'intérêt des fondations du chapitre 6.

CE QUE DISENT LES ÉTUDES SUR LE « CYCLE SYNCING »

Les phases relèvent de la physiologie, pas de la personnalité. Une méta-analyse de 2020 montre que la performance sportive n'est que très légèrement plus basse en début de phase folliculaire, avec des preuves de faible qualité ; les chercheurs conseillent une approche personnalisée plutôt que des règles rigides.²¹ Servez-vous des phases pour comprendre vos tendances, jamais pour vous limiter.

QUI FAIT QUOI.

Une orientation simple, pas une lecture de bilan. Un dosage hormonal n'a de sens que s'il est fait au bon moment du cycle et interprété par un professionnel de santé.

FSH · hormone folliculo-stimulante

Libérée par l'hypophyse en début de cycle, elle recrute les follicules dans l'ovaire.

Œstrogènes (estradiol)

Produits par le follicule en croissance. Ils reconstruisent la muqueuse utérine et produisent la glaire fertile. Ils soutiennent aussi les os, la peau et l'humeur.

LH · hormone lutéinisante

Elle connaît un pic brutal environ un jour à un jour et demi avant l'ovulation et déclenche la libération de l'ovule. Les tests d'ovulation la détectent.⁸

Progestérone

Produite après l'ovulation par le corps jaune. Elle stabilise la muqueuse, fait monter la température basale et a un effet apaisant, parfois un peu sédatif.

Prostaglandines

Messagers locaux qui font se contracter l'utérus. En excès, ils provoquent les crampes et parfois des selles molles pendant les règles. Les anti-inflammatoires (AINS) agissent en les réduisant.

Thyroïde, prolactine, cortisol, insuline

Ce ne sont pas des « hormones du cycle », mais chacune peut perturber l'ovulation. C'est pourquoi un médecin les vérifie souvent en cas de cycles irréguliers.

BON À SAVOIR

Saigner ne prouve pas qu'on a ovulé. Dans un **cycle anovulatoire**, il n'y a ni ovule ni hausse de progestérone, et pourtant des saignements peuvent survenir, souvent irréguliers ou plus abondants. Les courbes de température et l'observation de la glaire aident à faire la différence.

03

LES SIGNES DE FERTILITÉ

LA FERTILITÉ SE VOIT, QUAND ON SAIT OÙ REGARDER.

Observer sa fertilité, c'est lire des signes biologiques, pas se fier à une date calculée par une application. La fenêtre fertile ne dure pas tout le mois : environ **six jours**, les cinq jours qui précèdent l'ovulation et le jour même.^{5,6}

01

Glaire cervicale

Elle devient humide, glissante et filante à l'approche de l'ovulation. Elle permet aux spermatozoïdes de survivre jusqu'à environ cinq jours.

ANNONCE

02

Température basale

Elle monte d'environ 0,3 à 0,5 °C après l'ovulation, sous l'effet de la progestérone, et reste haute jusqu'aux règles.⁷

CONFIRME APRÈS COUP

03

Tests LH

Ils détectent le pic de LH dans les urines. Après un test positif, l'ovulation suit en général dans les deux jours.^{6,8}

PRÉVOIT, DE PEU

POURQUOI CROISER LES SIGNES

Chaque signe répond à une question différente. La glaire dit *l'ovulation approche peut-être*. Le test LH dit *c'est sans doute dans les deux jours*. La température dit *elle a eu lieu*. Ensemble, ils permettent de reconstituer chaque cycle avec confiance.

VOUS ESSAYEZ DE CONCEVOIR ?

Des rapports tous les un à deux jours pendant les jours de glaire glissante offrent les meilleures chances ; la probabilité est la plus forte autour du dernier jour de glaire glissante (le « jour sommet »).⁶ Inutile de tout chronométrer à l'heure près. Avant 35 ans après 12 mois d'essais, ou à partir de 35 ans après 6 mois, demandez un bilan de fertilité, plus tôt si vos cycles sont irréguliers ou absents.⁶

LA GLAIRE CERVICALE, EN PRATIQUE.

Notez la **sensation** à la vulve au fil de la journée (sèche, moite, humide, glissante), puis regardez ce qui se trouve sur le papier en vous essuyant avant d'aller aux toilettes. La sensation compte autant que l'aspect.³⁰

CE QUE VOUS REMARQUEZ	ASPECT OU SENSATION	CE QUE CELA PEUT SIGNIFIER
Sèche ou rien	Aucune sensation, rien de visible	Fertilité basse, souvent juste après les règles
Collante, pâteuse	Épaisse, grumeleuse, se casse facilement	Fertilité basse mais qui commence à monter
Crémeuse	Lisse, comme une lotion, blanche ou trouble	Fertilité en hausse ; les œstrogènes augmentent
Humide, glissante, filante	Claire, comme du blanc d'œuf cru, s'étire entre les doigts, sensation lubrifiée	Fertilité maximale ; l'ovulation est proche
Retour brutal au collant ou au sec	La sensation glissante s'arrête	Le dernier jour glissant est le « jour sommet » ; l'ovulation a lieu en général dans les un à deux jours qui l'entourent

CE QUI PEUT MODIFIER LA GLAIRE

La contraception hormonale, les infections vaginales, les lubrifiants, le sperme, l'allaitement, la périménopause, certains médicaments (comme les antihistaminiques) et la déshydratation.

CONSULTEZ SI LES PERTES

ont une odeur forte ou de poisson, sont vertes, grises ou mousseuses, ressemblent à du lait caillé, ou s'accompagnent de démangeaisons, brûlures, douleurs, saignements après les rapports ou fièvre.

TEMPÉRATURE, TESTS ET APPLICATIONS.

Température basale

- Prenez-la au réveil, avant de vous lever, à peu près à la même heure, avec un thermomètre précis au 0,05 °C.
- Cherchez une hausse durable d'environ 0,3 à 0,5 °C par rapport aux six mesures précédentes.
- L'alcool, la maladie, un sommeil court ou un voyage peuvent brouiller la courbe.

Tests LH urinaires

- Commencez quelques jours avant l'ovulation attendue, au moment de la journée indiqué dans la notice.
- Les faux positifs concernent environ 7 % des cycles.⁶
- En cas de SOPK (LH souvent élevée) ou en péri-ménopause, les résultats peuvent être trompeurs.

À PROPOS DES APPLICATIONS

Les applications qui prédisent l'ovulation à partir des seules dates ont trouvé le bon jour au mieux une fois sur cinq environ.⁶ Utilisez une application comme carnet pour vos propres observations, pas comme un oracle. Vérifiez sa politique de confidentialité : les données de cycle sont des données de santé sensibles.

À PROPOS DE LA CONTRACEPTION

N'utilisez pas les signes de fertilité pour éviter une grossesse sans avoir appris une méthode précise auprès d'une personne formée, et sans en suivre exactement les règles. En utilisation courante, l'ACOG rapporte 12 à 24 grossesses pour 100 femmes la première année ; en utilisation parfaite, moins de 1 à 5. Une application seule n'est pas une méthode.

SOUS CONTRACEPTION HORMONALE

Avec la pilule combinée, le patch ou l'anneau, l'ovulation est bloquée et les saignements mensuels sont des **hémorragies de privation**, pas de vraies règles : les signes de fertilité ne sont donc pas interprétables.²³ Le stérilet hormonal et certaines pilules progestatives ne bloquent souvent pas l'ovulation : le cycle et ses signes peuvent continuer.

04

LES SYMPTÔMES COMME SIGNAUX

NOTEZ VOS SYMPTÔMES COMME DES INFORMATIONS, PAS COMME UNE IDENTITÉ.

Un symptôme n'est pas un échec personnel. C'est un schéma. L'objectif est de relier son moment d'apparition à la phase du cycle, au sommeil, à l'alimentation, au stress, au mouvement et aux événements de vie.

Douleur

Crampes, douleurs pelviennes ou lombaires, douleur pendant les rapports, en allant à la selle ou en urinant, douleur d'ovulation.

Saignements

Jours abondants, caillots, débordements, saignements entre les règles, saignements après les rapports.

Humeur

Anxiété, irritabilité, tristesse, colère, manque de motivation, sentiment d'être débordée.

Énergie et sommeil

Fatigue, insomnie, réveils nocturnes, coups de barre l'après-midi, moindre résistance.

Peau et cheveux

Acné sur la mâchoire, peau grasse, cheveux qui s'affinent ou pilosité excessive.

Digestion

Ballonnements, constipation, diarrhée, nausées, fringales.

TROIS QUESTIONS POUR CHAQUE SYMPTÔME

1. **Quand ?** Avant les règles, pendant, autour de l'ovulation, après l'ovulation, ou au hasard ?
2. **Combien ?** Notez-le de 0 à 10, et ce qu'il vous a empêchée de faire.
3. **Qu'est-ce qui a aidé ?** Le repos, la chaleur, un antidouleur, l'alimentation, le mouvement, rien ?

NOTER LA DOULEUR DE FAÇON CONSTANTE

0-3 perceptible, la vie continue · **4-6** gênante, vous tenez le coup ou prenez un antidouleur · **7-10** vous annulez vos projets, manquez les cours ou le travail, ne dormez pas, ou les antidouleurs n'agissent pas. Des scores de 7 ou plus, répétés, justifient un avis médical.

SPM, TDPM OU AUTRE CHOSE ?

Beaucoup de personnes remarquent de légers changements avant les règles. Quand les symptômes deviennent sévères, ils méritent un nom et une vraie prise en charge.

	SYNDROME PRÉMENSTRUEL (SPM)	TROUBLE DYSPHORIQUE PRÉMENSTRUEL (TDPM)
Ce que c'est	Des symptômes physiques et émotionnels gênants pendant la phase lutéale	Une pathologie sévère, surtout émotionnelle, reconnue par le DSM-5-TR ¹⁹
Fréquence	Très fréquent sous une forme légère	Environ 2 à 6 % des personnes qui ont leurs règles ¹⁹
Signes typiques	Ballonnements, seins tendus, irritabilité, fatigue, fringales	Déprime, anxiété, colère ou sautes d'humeur marquées, qui abîment les relations, le travail ou les études
Calendrier	Les symptômes apparaissent la dernière semaine avant les règles, s'atténuent dans les jours qui suivent leur début, et sont faibles ou absents la semaine d'après.	
Diagnostic	Il repose sur une notation quotidienne des symptômes pendant au moins deux cycles . C'est exactement ce que les fiches du chapitre 7 vous aident à recueillir. Des traitements efficaces existent, des mesures d'hygiène de vie aux médicaments. ²⁰	

ÉCARTER LES RESSEMBLANCES

Si les symptômes sont présents tout le mois et s'aggravent seulement avant les règles, il peut s'agir d'une **exacerbation prémenstruelle** d'un autre trouble (dépression, anxiété, migraine, intestin irritable). C'est le calendrier qui permet de les distinguer.

N'ATTENDEZ PAS

Le TDPM est associé à un risque plus élevé d'idées suicidaires. Si vous avez des idées de vous faire du mal, à n'importe quel moment du cycle, appelez aujourd'hui le 3114 (France), le 15 ou le 112 ; 9-8-8 au Canada.

05

QUAND CONSULTER

AVOIR MAL EST FRÉQUENT. NE PAS ÊTRE ÉCOUTÉE NE DEVRAIT PAS L'ÊTRE.

Ces listes vous aident à décider à quelle vitesse agir. Si vos règles sont en retard ou absentes et qu'une grossesse est possible, **faites d'abord un test de grossesse.**¹²

AUJOURD'HUI · URGENCES

- Une serviette ou un tampon traversé toutes les heures pendant deux heures ou plus, ou des saignements abondants avec vertiges, malaise, essoufflement ou cœur qui s'emballe.
- Une douleur pelvienne brutale et intense, une douleur d'un côté avec saignements, une douleur à l'épaule ou un malaise, surtout si une grossesse est possible (risque de grossesse extra-utérine).
- Une douleur pelvienne avec fièvre, ou des signes de choc toxique avec un tampon ou une coupe en place.

DANS LES SEMAINES QUI VIENNENT · PRENEZ RENDEZ-VOUS

- Des règles si douloureuses qu'elles vous font manquer les cours, le travail ou le sommeil, ou que les antidouleurs ne soulagent plus.^{13,15}
- Une douleur qui s'aggrave avec le temps, une douleur pendant les rapports, ou une douleur cyclique en allant à la selle ou en urinant.
- Des règles abondantes (voir page suivante), ou une fatigue et un essoufflement qui peuvent signaler un manque de fer.
- Des saignements entre les règles ou après les rapports.¹⁰
- Des cycles régulièrement plus courts que 24 jours ou plus longs que 38 jours, ou dont la durée varie de plus de 7 à 9 jours.^{2,3}
- Pas de règles depuis 3 mois si vos cycles étaient réguliers, ou depuis 6 mois s'ils étaient irréguliers.¹²
- Une acné nouvelle, une pilosité excessive ou une chute de cheveux avec des cycles irréguliers ; un écoulement de lait par les mamelons.
- Tout saignement survenant un an ou plus après vos dernières règles (saignement post-ménopausique).²⁹

« CE SYMPTÔME AFFECTE MA VIE QUOTIDIENNE. J'AIMERAIS COMPRENDRE CE QUI PEUT L'EXPLIQUER ET QUELS EXAMENS SONT ADAPTÉS. »

RÈGLES ABONDANTES, RÈGLES ABSENTES, ÂGES PARTICULIERS.

Mes règles sont-elles abondantes ?

Les médecins définissent les règles abondantes comme des pertes de sang qui retentissent sur votre qualité de vie physique, sociale, émotionnelle ou matérielle.¹⁰ Signes concrets :⁹

- Traverser une ou plusieurs serviettes ou tampons toutes les heures pendant plusieurs heures.
- Devoir porter deux protections à la fois, ou se lever la nuit pour changer.
- Des caillots de la taille d'une grosse pièce (2,5 cm) ou plus.
- Des saignements qui durent plus de 7 jours.

Pourquoi c'est important

Les règles abondantes sont une cause majeure de **carence en fer**, avec ou sans anémie : fatigue, essoufflement, chute de cheveux, difficultés de concentration. Demandez si une numération sanguine et un dosage de ferritine sont utiles.^{10,11}

Environ 1 adolescente sur 5 explorée pour des règles abondantes a un **trouble de la coagulation**, le plus souvent une maladie de Willebrand. Signalez les bleus faciles, les saignements de nez ou des antécédents familiaux.¹¹

Adolescentes

Les cycles peuvent être irréguliers pendant quelques années après les premières règles. Consultez tout de même en l'absence de règles à 15 ans (ou 3 ans après le début du développement des seins), si un cycle dépasse 90 jours, ou si les règles durent plus de 7 jours.¹

Périménopause

À partir de la quarantaine, les cycles deviennent plus variables. Un écart persistant de 7 jours ou plus entre deux cycles, puis des intervalles de 60 jours ou plus, sont des étapes habituelles.²⁴ Des règles très abondantes, très rapprochées ou des saignements entre les règles méritent tout de même un contrôle.

L'ABSENCE DE RÈGLES EST UN SYMPTÔME, PAS UN DIAGNOSTIC

Une fois la grossesse écartée, les causes les plus fréquentes sont un apport d'énergie insuffisant (manger trop peu, entraînement intense, perte de poids), le stress, le SOPK, un trouble thyroïdien, une prolactine élevée et, plus rarement, une insuffisance ovarienne précoce. L'absence de règles peut fragiliser les os à long terme : elle mérite un bilan plutôt que de l'attente.^{12,22}

DES PATHOLOGIES À CONNAÎTRE PAR LEUR NOM.

Une page de vocabulaire, pas de diagnostic : elle vous aide à décrire ce que vous vivez et à comprendre ce qu'un médecin peut rechercher.

Endométriose

Un tissu proche de la muqueuse utérine se développe hors de l'utérus. Elle touche environ 10 % des femmes et des jeunes filles en âge de procréer.¹⁶ Règles douloureuses, douleurs pelviennes chroniques, douleur pendant les rapports, troubles digestifs ou urinaires, fatigue, parfois infertilité. L'intensité de la douleur ne reflète pas l'étendue de la maladie. Le diagnostic prend souvent plusieurs années ; les recommandations actuelles permettent un diagnostic clinique et par imagerie, et une échographie normale ne l'exclut pas.^{13,14,15}

SOPK

Le syndrome des ovaires polykystiques touche environ 10 à 13 % des femmes.¹⁷ Chez l'adulte, le diagnostic repose sur deux critères parmi : ovulation irrégulière ou absente, signes d'excès d'androgènes (acné, pilosité, prise de sang), ovaires d'aspect polykystique à l'échographie ou AMH élevée. Chez l'adolescente, l'échographie et l'AMH ne sont pas utilisées. Il a des dimensions métaboliques, émotionnelles et de santé à long terme. Un consensus international a proposé en 2026 un nouveau nom, PMOS (syndrome ovarien métabolique polyendocrinien) ; les critères de 2023 restent en vigueur.¹⁸

Adénomyose

Du tissu proche de la muqueuse se trouve dans le muscle de l'utérus. Règles abondantes et douloureuses, sensation de pesanteur pelvienne, plus souvent diagnostiquée après 35 ans. Détectée par échographie ou IRM.

Fibromes et polypes

Des formations de l'utérus, le plus souvent bénignes. Elles peuvent causer des règles abondantes ou prolongées, des saignements entre les règles, une pesanteur ou des envies d'uriner fréquentes.

Thyroïde et prolactine

Une thyroïde trop ou pas assez active, ou une prolactine élevée, peuvent modifier la durée du cycle, le flux, l'énergie, l'humeur, la température et la fertilité. Une simple prise de sang permet de les vérifier.

Aménorrhée hypothalamique fonctionnelle

Le cerveau met l'ovulation en pause quand l'énergie apportée ne couvre pas les besoins liés à l'entraînement, à une perte de poids ou au stress. Ce diagnostic se pose après avoir écarté les autres causes ; la récupération passe par une alimentation suffisante et du repos, avec un suivi médical.²²

LA SANTÉ HORMONALE N'EST PAS UNE ASTUCE.

Le cycle répond au corps tout entier. Le but n'est pas de tout contrôler, mais de réunir les conditions qui rendent l'ovulation, la récupération et le calme plus probables. Sans peur et sans perfection : qu'est-ce que vous pouvez *ajouter* pour soutenir votre corps ?

Assez d'énergie

Manger suffisamment et régulièrement est la base. Un apport insuffisant chronique est l'une des causes les plus fréquentes d'arrêt de l'ovulation.²²

PREUVES SOLIDES

Le sommeil

Un sommeil régulier et la lumière du matin soutiennent l'horloge biologique, la régulation de l'appétit et la tolérance à la douleur.

BONNES PREUVES

Le stress

Le système du stress et le système reproducteur communiquent. Une tension chronique peut retarder l'ovulation et amplifier les symptômes prémenstruels.

BONNES PREUVES

Le mouvement

Une activité régulière, y compris le renforcement musculaire et la marche, soutient le métabolisme, l'humeur et les douleurs de règles. Adaptez l'intensité à vos sensations, pas à un calendrier.

BONNES PREUVES

Chaleur et antidouleurs

La chaleur locale et, s'ils vous conviennent, les anti-inflammatoires pris dès les premières douleurs sont le traitement de première intention des crampes. Demandez conseil à votre pharmacien ou médecin.

BONNES PREUVES

Alcool et tabac

Tous deux dégradent le sommeil et les symptômes prémenstruels, et le tabac est associé à des règles plus douloureuses et à une ménopause plus précoce.

BONNES PREUVES

À PROPOS DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Peu de compléments ont fait leurs preuves sur les symptômes du cycle, et certains interagissent avec des médicaments ou la pilule. Parlez-en à un médecin ou un pharmacien plutôt que de les accumuler.

UNE ASSIETTE QUI SOUTIENT LE CYCLE, SANS CULTURE DU RÉGIME.

- **Des protéines** à chaque repas, pour la satiété, la réparation des tissus et une énergie plus stable.
- **Des fibres et des couleurs** (légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes) pour la digestion et un microbiote varié.
- **Des glucides comme carburant**, surtout autour de l'entraînement et en phase lutéale, quand l'appétit augmente naturellement.
- **De bonnes graisses** (poissons gras, huile d'olive, noix, graines) pour absorber les vitamines A, D, E et K.
- **Des aliments riches en fer** si vos règles sont abondantes, associés à de la vitamine C pour mieux l'absorber.

SI VOUS ESSAYEZ DE CONCEVOIR

Aucun régime particulier n'a montré qu'il améliorerait la fertilité naturelle.⁶ Une mesure est clairement prouvée : **l'acide folique (vitamine B9), 400 µg par jour**, à commencer au moins 4 semaines avant la conception et à poursuivre jusqu'à 8 semaines après, selon les recommandations françaises, pour réduire le risque d'anomalies du tube neural.²⁶ Votre médecin peut conseiller une dose plus forte dans certaines situations.

LES ÉTAPES DE VIE QUI CHANGENT LA DONNE

À l'arrêt d'une contraception hormonale

La plupart des personnes ovulent de nouveau en quelques mois. Les symptômes que la pilule masquait (acné, douleurs, cycles irréguliers) peuvent revenir. Si les règles ne sont pas revenues au bout de trois mois, consultez.

Après une grossesse

L'allaitement retarde souvent le retour de l'ovulation et des règles, mais une ovulation peut survenir avant les premières règles. La glaire et la température sont plus difficiles à interpréter.

Les premières années après les premières règles

Des cycles irréguliers sont fréquents le temps que le dialogue entre cerveau et ovaires se mette en place. Des douleurs sévères ou des règles très abondantes ne font pas partie du fait de « grandir ».

Périménopause

Souvent à partir du début ou du milieu de la quarantaine : cycles plus courts ou plus longs, règles plus abondantes, troubles du sommeil et de l'humeur, bouffées de chaleur. Des accompagnements et des traitements existent.

CINQ CHOSES, UNE LIGNE PAR JOUR.

Restez légère. Observez un à trois cycles. Vous cherchez des tendances, pas la perfection.

01

Saignements

0 rien · T traces · 1 léger · 2 moyen · 3 abondant · 4 très abondant. Ajoutez « C » pour les caillots.

02

Glaire

S sèche · Co collante · Cr crémeuse · H humide · G glissante ou filante. Entourez le jour sommet.

03

Température (facultatif)

Au réveil, avant de vous lever, à la même heure chaque jour. Notez ce qui peut la perturber.

04

Symptômes

Douleur, humeur, énergie, sommeil, digestion, peau : une note de 0 à 10 pour les un ou deux qui comptent le plus pour vous.

05

Contexte

Stress, voyage, maladie, alcool, entraînement intense, nouveau médicament, grands événements de vie. Le contexte explique beaucoup de cycles « bizarres ».

LA RÈGLE DE LA PETITE OBSERVATION

Si noter vous rend anxieuse, simplifiez : les saignements et votre symptôme principal suffisent. Si vous avez déjà eu une relation difficile avec l'alimentation ou votre corps, ne suivez ni votre poids ni les quantités que vous mangez.

UN CYCLE, UNE PAGE

Début du cycle : _____ Cycle n° : ____

JOUR	DATE	SAIGN.	GLAIRE	TEMP. °C	DOULEUR 0-10	HUMEUR 0-10	ÉNERGIE 0-10	NOTES ET CONTEXTE
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								

Saignements : 0 · T · 1 · 2 · 3 · 4 (+C caillots) | Glaire : S · Co · Cr · H · G (entourez le jour sommet) | Imprimez une page par cycle, ou recopiez les colonnes dans votre application de notes.

VOIR VOTRE SCHÉMA APPARAÎTRE.

À LA FIN DE CHAQUE CYCLE	CYCLE 1	CYCLE 2	CYCLE 3
Date de début			
Durée du cycle (jours)			
Jours de règles / jour le plus abondant			
Protections le jour le plus abondant			
Caillots ? Changes la nuit ?			
Saignements entre les règles ?			
Jour sommet de la glaire			
Jour de hausse de température			
Phase lutéale (de la hausse aux règles)			
Douleur max. / jours manqués			
Symptôme principal et son moment			
Jours de meilleure énergie			
Jours de plus faible énergie			
Sommeil et stress dans l'ensemble			

QU'EST-CE QUI A CHANGÉ CE MOIS-CI, ET QUE VEUX-JE DEMANDER ?

APPORTEZ LE SCHÉMA, PAS SEULEMENT LA DOULEUR.

Les consultations sont courtes. Une histoire organisée aide votre médecin à vous comprendre plus vite et à prescrire les bons examens. Pas besoin de réponses parfaites, juste d'un point de départ clair.

Chronologie

Depuis quand ? Un déclencheur : changement de contraception, grossesse ou perte, infection, nouveau médicament, déménagement, période stressante ?

Schéma du cycle

Durée moyenne et écart des cycles, jours de règles, jour le plus abondant, traces, règles absentes. Apportez les fiches 1 et 2.

Vos trois principaux symptômes

Ce qui pèse le plus sur votre vie, sa note, et à quel moment du cycle il apparaît. Ce qu'il vous empêche de faire.

Contexte médical

Diagnostics, médicaments et compléments, historique de contraception, chirurgies, examens précédents, antécédents familiaux (endométriose, SOPK, troubles de la coagulation, thyroïde).

Votre objectif

Moins de douleur, des règles moins abondantes, comprendre des cycles irréguliers, arrêter la pilule, concevoir, traverser la périménopause, ou simplement comprendre votre corps. Le dire clairement aide le médecin à cibler.

QUESTIONS QUE VOUS POUVEZ POSER

- ☐ Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces symptômes, et que vérifieriez-vous en premier ?
- ☐ Une prise de sang (numération, ferritine, thyroïde, hormones au bon moment du cycle) ou une échographie serait-elle utile pour moi ?
- ☐ Quelles sont mes options de traitement, et leurs effets secondaires ?
- ☐ Qu'est-ce qui doit me faire revenir plus tôt ?

POUR MON RENDEZ-VOUS DU ____ / ____ /

MA PRÉOCCUPATION PRINCIPALE, EN UNE PHRASE

MON OBJECTIF POUR CE RENDEZ-VOUS

DURÉE MOYENNE DU CYCLE / ÉCART

JOURS DE RÈGLES / JOUR LE PLUS ABONDANT

SYMPTÔME 1 · NOTE · MOMENT DU CYCLE

SYMPTÔME 2 · NOTE · MOMENT DU CYCLE

SYMPTÔME 3 · NOTE · MOMENT DU CYCLE

JOURS MANQUÉS (TRAVAIL, COURS, VIE SOCIALE) PAR CYCLE

MÉDICAMENTS, COMPLÉMENTS, CONTRACEPTION ACTUELS

CE QUE J'AI DÉJÀ ESSAYÉ, ET LE RÉSULTAT

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX UTILES

GROSSESSE POSSIBLE ? DÉBUT DES DERNIÈRES RÈGLES

MES QUESTIONS

LA MÉTHODE INNER RHYTHM.

Ce guide est un point de départ. En séances individuelles en ligne, en français ou en anglais, nous allons plus loin, à votre rythme, en quatre étapes.

01

Comprendre

Nous reprenons votre histoire, votre cycle et vos symptômes, et regardons ce qui revient d'un cycle à l'autre.

02

Poser les bases

Nous ajustons quelques habitudes : alimentation, sommeil, digestion, stress. Peu de choses, mais que vous pouvez tenir.

03

Lire votre cycle

Vous apprenez à lire votre cycle et à repérer ce dont vous avez besoin selon les moments.

04

Trouver votre équilibre

Vous gardez ce qui marche pour vous et continuez seule, sans dépendre de moi.

CE QUE C'EST

- De la connaissance de soi et un accompagnement concret et personnalisé.
- Une aide pour préparer vos rendez-vous médicaux et comprendre ce qui s'y dit.
- Un espace où vos symptômes sont pris au sérieux.

CE QUE CE N'EST PAS

- Un diagnostic, une prescription ou un substitut à votre médecin.
- Un protocole miracle de compléments ou un programme minceur.
- Un endroit où l'on minimise votre douleur.

PRÊTE À COMPRENDRE CE QUE VOTRE CORPS ESSAIE DE VOUS DIRE ?

Réservez un appel gratuit et sans engagement de 15 à 20 minutes.

THECYCLESPLACE.COM · RÉSERVER UN APPEL GRATUIT

QUELQUES MOTS, SIMPLEMENT.

Aménorrhée

Absence de règles : 3 mois sans saignement après des cycles réguliers, 6 mois après des cycles irréguliers.

Cycle anovulatoire

Un cycle sans ovulation. Des saignements peuvent quand même survenir.

Corps jaune

La structure qui reste dans l'ovaire après l'ovulation. Il produit la progestérone.

Dysménorrhée

Règles douloureuses. Primaire : sans pathologie sous-jacente. Secondaire : due à une pathologie, comme l'endométriose.

Fenêtre fertile

Environ six jours par cycle pendant lesquels un rapport peut aboutir à une grossesse.

Hémorragie de privation

Saignement provoqué par l'arrêt des hormones, par exemple pendant la semaine sans pilule. Ce ne sont pas de vraies règles.

Jour sommet

Le dernier jour de glaire glissante, la plus fertile.

Pic de LH

La montée rapide de l'hormone lutéinisante qui déclenche l'ovulation.

Phase lutéale

De l'ovulation aux règles suivantes, quand la progestérone est plus élevée.

Ovulation

Libération d'un ovule par l'ovaire. L'ovule survit environ 12 à 24 heures.

Règles abondantes

Pertes de sang qui retentissent sur la qualité de vie. Remplace l'ancien terme « ménorragie ».

Saignement utérin anormal

Tout saignement en dehors des limites habituelles de rythme, de régularité, de durée ou d'abondance.

TDPM

Trouble dysphorique prémenstruel : des symptômes émotionnels prémenstruels sévères qui perturbent la vie.

Température basale

Température au repos, au réveil. Elle monte après l'ovulation.

DES SOURCES VISIBLES.

1. ACOG Committee Opinion 651. Menstruation in girls and adolescents: using the menstrual cycle as a vital sign. 2015, réaffirmé en 2025.
2. Munro MG et al. The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms (revised). *Int J Gynaecol Obstet* 2018;143:393–408.
3. Jain V, Munro MG, Critchley HOD. Contemporary evaluation of women and girls with abnormal uterine bleeding: FIGO Systems 1 and 2. *Int J Gynaecol Obstet* 2023.
4. Bull JR et al. Real-world menstrual cycle characteristics of more than 600,000 menstrual cycles. *NPJ Digit Med* 2019;2:83.
5. Wilcox AJ et al. Timing of sexual intercourse in relation to ovulation. *N Engl J Med* 1995;333:1517–21.
6. ASRM Practice Committee. Optimizing natural fertility: a committee opinion. *Fertil Steril* 2022;117:53–63.
7. ACOG. Fertility awareness-based methods of family planning (FAQ024). Revu en 2025.
8. Food and Drug Administration (États-Unis). Ovulation (urine test). Tests à domicile.
9. ACOG. Heavy menstrual bleeding (FAQ193). Revu en 2026.
10. NICE, recommandation NG88. Heavy menstrual bleeding: assessment and management. 2018, mise à jour 2026.
11. ACOG Committee Opinion 785. Screening and management of bleeding disorders in adolescents with heavy menstrual bleeding. 2019, réaffirmé en 2023.
12. ASRM Practice Committee. Current evaluation of amenorrhea: a committee opinion. *Fertil Steril* 2024;122:52–61.
13. ACOG Clinical Practice Guideline 11. Diagnosis of endometriosis. 2026.
14. ESHRE. Recommandation sur l'endométriose. 2022.
15. NICE, recommandation NG73. Endometriosis: diagnosis and management. 2017, mise à jour 2024.
16. Organisation mondiale de la santé. Endométriose, aide-mémoire. 2025.
17. Teede HJ et al. International evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. 2023.
18. Teede HJ et al. Renaming polycystic ovary syndrome: polyendocrine metabolic ovarian syndrome. *Lancet* 2026.
19. American Psychiatric Association. DSM-5-TR. 2022 ; Reilly TJ et al. Prevalence of PMDD: systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord* 2024;349:534–40.
20. ACOG Clinical Practice Guideline 7. Management of premenstrual disorders. 2023.
21. McNulty KL et al. The effects of menstrual cycle phase on exercise performance in eumenorrheic women. *Sports Med* 2020;50:1813–27.
22. Mountjoy M et al. 2023 IOC consensus statement on relative energy deficiency in sport (REDs). *Br J Sports Med* 2023;57:1073–97.
23. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. Combined hormonal contraception. 2019, modifié en 2023.
24. Harlow SD et al. Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop +10 (STRAW+10). 2012.
25. ACOG Committee Opinion 557. Management of acute abnormal uterine bleeding in nonpregnant reproductive-aged women. 2013, réaffirmé.
26. ANSM, résumé des caractéristiques de l'acide folique 0,4 mg ; Santé publique France, « Je pense bébé, je pense B9 ». Voir aussi OMS.
27. Food and Drug Administration (États-Unis). The facts on tampons and how to use them safely.
28. ACOG Practice Bulletin 193. Tubal ectopic pregnancy. 2018, réaffirmé en 2025.
29. ACOG Committee Opinion 734. The role of transvaginal ultrasonography in evaluating the endometrium of women with postmenopausal bleeding. 2018, réaffirmé en 2023.
30. World Organization Ovulation Method Billings (WOOMB). La méthode de l'ovulation Billings : le Sommet de fertilité.

POUR FINIR

VOTRE CORPS N'EST PAS LE PROBLÈME. C'EST UN SYSTÈME À COMPRENDRE.

Commencez par observer. Ajoutez le contexte. Posez de meilleures questions. Faites-vous accompagner quand vos symptômes pèsent sur votre vie. C'est le début de la connaissance de votre corps.



Contenu éducatif, vérifié au regard des recommandations cliniques en vigueur en octobre 2026. Ce n'est ni un outil de diagnostic, ni une méthode de contraception, ni un substitut à des soins médicaux. Consultez en urgence en cas de douleur intense, de malaise, de règles abondantes avec vertiges, de fièvre, de complication possible de grossesse, ou de tout symptôme qui vous inquiète.

THECYCLESAPCE.COM · @ELSA.THECYCLESAPCE · HELLO@THECYCLESAPCE.COM

© 2026 The Cycle Space · Édition 2